

แผนสอนและเตรียมสาธิต

เปรมศักดิ์ เทพวงสา

นักวิชาการชำนาญการ โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ

กำหนดการแนะนำ 90 นาที

ภาพรวม 15 นาที / สาธิต 35 นาที / ฝึกปฏิบัติ 25 นาที / ถามตอบและตกลงแนวทางเริ่มใช้ 15 นาที

ก่อนผู้เข้าอบรมเข้าห้อง

1. เปิด PDF สไลด์และ backdrop ทดสอบจอและตัวอักษรภาษาไทย
2. ผู้ดูแลยืนยัน URL ระบบ บัญชีฝึก และสิทธิ์เมนูของผู้เรียน
3. เตรียมหนึ่ง visit ทดสอบสำหรับสาธิต OPD และหนึ่งตัวอย่างผลปฎิเสธ
4. ใช้ข้อมูลสมมติหรือข้อมูลปกปิดตัวตน ปิดหน้าต่างที่มีรหัสผ่านและข้อมูลผู้ป่วย
5. ตกลงกับผู้ดูแลว่าจะสาธิตถึง Preview ไม่กดส่ง API หรือเขียนกลับข้อมูลจริงระหว่างฝึก

หากระบบยังไม่พร้อมเชื่อมต่อ

ใช้สไลด์และภาพหน้าคู่มือประกอบ ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกบนกระดาษและอธิบายขั้นตอน แยกการติดตั้งระบบเป็นงานติดตามกับ IT

ผลลัพธ์ที่ต้องได้

ผู้เรียนค้นหา visit ได้ อธิบายข้อมูลที่ขาดได้ และระบุผู้รับผิดชอบกับขั้นตอนติดตามหลังส่งได้

แนวพุดสไลด์ 1–4

1. FDH Checker

กล่าวต้อนรับบุคลากรโรงพยาบาลวชิรภูมิ แนะนำตัว เปรมศักดิ์ เทพวงสา นักวิชาการชำนาญการ โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ วันนี้เรียนรู้วิธีตรวจสอบความพร้อมก่อนส่งและติดตามผลหลังส่ง ใช้อย่างสมมติ ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยจริงบนจอ

2. เป้าหมายการอบรม

ถามผู้เข้าอบรมว่าใครทำงานเวชระเบียน งานเคลม งานการเงิน และ IT เพื่อเลือกตัวอย่างให้ตรงบทบาท ไม่สัญญาว่าระบบจะเพิ่มรายได้เป็นตัวเลขหากยังไม่มีผลจริง

อ้างอิงโปรแกรม: README.md

3. กำหนดการแนะนำ 90 นาที

เวลาเป็นแนวทางสำหรับวิทยากร สามารถลดเหลือ 60 นาทีโดยย่อส่วน IPD/การเงินและให้ฝึกเพียงหนึ่งเคส ไม่ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการตั้งคำถามข้อมูล

4. FDH Checker ช่วยงานส่วนไหน

ความสามารถอ้างอิงโค้ดในชุดปัจจุบัน ความพร้อมของแต่ละโรงพยาบาลขึ้นกับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล สิทธิผู้ใช้ และการตั้งค่าระบบปลายทาง

อ้างอิงโปรแกรม: README.md; src/config/menuDefinitions.ts

แนวพุดสไลด์ 5–8

5. วงจรการทำงานของหนึ่ง visit

อธิบายทีละขั้น โดยแยกการบันทึกข้อมูล การส่งข้อมูล และการได้รับเงินออกจากกัน ให้ผู้เรียนบอกว่าตนรับผิดชอบขั้นตอนไหน

อ้างอิงโปรแกรม: README.md

6. บทบาทในการใช้งานร่วมกัน

นี้เป็นข้อเสนอการแบ่งงาน ต้องตกลงผู้รับผิดชอบจริงของโรงพยาบาล ไม่ควรให้ทุกคนใช้บัญชีเดียวกัน

อ้างอิงโปรแกรม: src/config/menuDefinitions.ts; src/pages/LoginPage.tsx

7. เมนูหลักที่ใช้ในการสาธิต

ชี้ตำแหน่งเมนูตามสิทธิที่ได้รับ เมนูที่มองไม่เห็นอาจเกิดจากสิทธิผู้ใช้ ไม่ใช่ข้อมูลหาย ชื่อเมนูอ้างอิง menuDefinitions

อ้างอิงโปรแกรม: src/config/menuDefinitions.ts

8. เริ่มต้นเข้าสู่ระบบ

สาธิตล็อกอินด้วยบัญชีฝึกอบรม ไม่แสดงรหัสผ่านหรือค่าเชื่อมต่อฐานข้อมูลบนจอ URL ใน README เป็นเครื่องพัฒนา อย่านำ localhost ไปบอกผู้เข้าอบรมว่าเป็น URL โรงพยาบาลวชิรภูมิ

อ้างอิงโปรแกรม: src/pages/LoginPage.tsx; src/config/menuDefinitions.ts

แนวพุดสไลด์ 9–12

9. ค้นหา visit ในรายการ OPD

คลิก รายการ OPD เลือกวันเริ่มและวันสิ้นสุด กด ดึงข้อมูลใหม่ สาธิตกรองข้อมูลรอแก้ไข แล้วเปลี่ยนกลับทั้งหมด เน้นตรวจ VN และวันรับบริการก่อนเปิดรายละเอียด

อ้างอิงโปรแกรม: src/pages/StaffPage.tsx

10. จุดตรวจในรายละเอียด visit

เปิดหนึ่ง visit ให้ผู้เรียนไล่ตรวจทั้งสองฝั่ง หากพบข้อมูลไม่ตรงให้ตรวจต้นทางก่อนแก่ การมีคำสั่ง Lab ไม่เท่ากับมีค่าผล และมี Diag อย่างเดียวไม่ยืนยันว่ามีบริการที่เรียกเก็บ

อ้างอิงโปรแกรม: src/components/DetailModal.tsx; src/config/fundOperationalGuideCatalog.ts

11. คู่มือกองทุนในโปรแกรม

เปิด คู่มือกองทุน พิมพ์ ANC หรือ Z30.4 ให้ดูว่าช่องค้นหารายการตามคำค้น หน้านี้ครอบคลุมรายชื่อกองทุนที่กำหนดในโปรแกรม แต่ไม่ได้แปลว่าหน่วยบริการมีสิทธิเบิกทุกกองทุน

อ้างอิงโปรแกรม: src/pages/GuidePage.tsx

12. Diag หักถการ และ ADP คนละข้อมูล

ใช้ตัวอย่างตรวจฟัน ANC ในคู่มือเพื่อชี้ว่าแต่ละรหัสเป็นคนละช่อง ไม่ให้ผู้เรียนคัดลอกรหัสเพียงเพื่อทำให้สถานะผ่าน ต้องตรวจข้อเท็จจริงและรหัสย่อยที่เหมาะสม

อ้างอิงโปรแกรม: src/config/fundOperationalGuideCatalog.ts; src/utills/ancDentalRules.ts

แนวพุดสไลด์ 13–16

13. ตัวอย่างฝึก ANC Visit

ตั้งโจทย์ว่ามี Diag และข้อมูลครรภ์ แต่ยังไม่พบ ADP 30011 ถามผู้เรียนว่าต้องตรวจอะไร คำตอบคือยืนยันว่ามีบริการ ANC Visit จริง ตรวจรายการค่าใช้จ่ายและการผูกรหัส แล้วให้ผู้รับฝึกหัดตอบแก้ต้นทางและดึงข้อมูลใหม่

อ้างอิงโปรแกรม: src/config/fundDefinitions.ts; src/pages/SpecificFundPage.tsx

14. ตัวอย่างคู่รหัสคุมกำเนิด

อธิบายว่ารหัสแสดงแบบไม่มีจุดตามตารางในโปรแกรม FP003_3 มีเกณฑ์ในโปรแกรมไม่เกิน 2 แผงต่อปี FP003_4 ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี ให้เปิดคู่มือประกอบและตรวจประวัติทั้งปี ไม่ใช่จำนวนที่เห็นเฉพาะช่วงวันที่ค้นหา

อ้างอิงโปรแกรม: src/utills/familyPlanningRules.ts

15. การอ่าน Checklist รายบริการ

เปิดรายละเอียดกองทุนในหน้าคู่มือ ชี้ว่าเงื่อนไขไม่ใช่รายการที่ระบบตรวจอัตโนมัติครบทุกข้อ ขยายตัวอักษรบนเครื่องสาธิตตามขนาดจอ

อ้างอิงโปรแกรม: src/config/fundOperationalGuideCatalog.ts

16. Lab และยา ต้องมีหลักฐานบริการ

ไม่ใช่ตารางเป็นคำสั่งรักษา หากไม่พบยาหรือชื่อ Lab ที่ใช้จริง ให้ตรวจการตั้งค่ารหัสและรายงานผู้ดูแล ระบบอาจค้นหาจากทั้งรหัสและชื่อรายการ

อ้างอิงโปรแกรม: src/config/fundOperationalGuideCatalog.ts; src/utills/herbalMedicationRules.ts

แนวพุดสไลด์ 17–20

17. การแก้ไขข้อมูลและตรวจซ้ำ

ระบบมีฟังก์ชันช่วยเติมข้อมูลบางรายการซึ่งอาจเขียนกลับ HOSxP ก่อนใช้ต้องอ่านรายการเปลี่ยนแปลงและข้อความยืนยัน เคสฝึกไม่ควรยืนยันบันทึกข้อมูลผู้ป่วยจริง

อ้างอิงโปรแกรม: src/pages/SpecificFundPage.tsx

18. Checklist ก่อนส่งออก

เน้นว่ารายการบางกองทุนไป KTB หรือระบบเฉพาะ และงานพอกเข้าใช้ตรวจข้อมูล 43 แฟ้ม ไม่เลือกส่งทุกกองทุนผ่าน FDH โดยอัตโนมัติ

อ้างอิงโปรแกรม: src/config/fundDefinitions.ts; src/config/fundOperationalGuideCatalog.ts

19. สาริตส่งออก OPD

สำคัญ: หน้าส่งออกมีพฤติกรรมเมื่อไม่เลือกรายการ อาจใช้รายการพร้อมส่งที่มองเห็นทั้งหมด ต้องอ่านจำนวน เลือกส่ง ก่อนทุกครั้ง ไม่ยืนยันส่งซ้ำโดยไม่ตรวจประวัติ การส่งจริงให้ผู้รับผิดชอบโรงพยาบาลเป็นผู้ยืนยัน

อ้างอิงโปรแกรม: src/pages/FDHCheckerPage.tsx; README.md

20. สถานะหลังส่งมีหลายชั้น

อธิบาย REP และ STM ตามประเภทไฟล์ที่หน่วยงานใช้จริง สถานะรับไฟล์ไม่ใช่การยืนยันว่าทุกรายการได้รับการจ่ายให้ดูรายละเอียดต่อรายการ

อ้างอิงโปรแกรม: README.md; src/pages/RepStmImportPage.tsx

แนวพุดสไลด์ 21–24

21. นำเข้า REP/STM และแก้ C/Deny

ห้ามส่งซ้ำทันทีเพราะพบ Deny ต้องอ่านเหตุผลและแนวทางของรายการก่อน นำเข้าข้อมูลในระบบฝึกหรือไฟล์ที่ปิดข้อมูลแล้วเท่านั้น

อ้างอิงโปรแกรม: src/pages/RepStmImportPage.tsx; src/pages/RepDenyPage.tsx

22. การเงินและงาน IPD ที่ต่อยอดได้

ส่วนนี้เป็นภาพรวม ไม่ควรอธิบายว่าใช้เกณฑ์ OPD แทน IPD ให้จัดรอบสอนเฉพาะงาน IPD/บัญชีเพิ่มเติมตามผู้รับผิดชอบ

อ้างอิงโปรแกรม: src/config/menuDefinitions.ts

23. แบบฝึก A ค้นหาจุดที่ขาด

เฉลย: ตรวจเพศและกลุ่ม Diag ผ่าศรักร์ ตรวจบริการ ANC จริงและรายการค่าใช้จ่าย ตรวจการผูกรหัส ADP ไม่เต็มรหัสทันที ถ้ามีหลักฐานและผู้มีสิทธิ์แก้ต้นทางแล้วจึงโหลด VN เดิมใหม่และตรวจผล ไม่กดส่งเคลมจริง

24. แบบฝึก B อ่านผลหลังส่ง

เฉลย: ยังไม่สรุปว่าได้รับเงิน ตรวจเหตุผลปฏิเสธและจับคู่ให้ถูก visit ตรวจข้อมูลต้นทางแล้วกำหนดการแก้หรือติดตาม ไม่ส่งซ้ำโดยไม่ทราบสาเหตุ และตรวจ STM/รายการรับชำระเมื่อมีข้อมูลเข้ามา

แนวพุดสไลด์ 25–28

25. ปัญหาที่พบบ่อยระหว่างใช้งาน

หากแกร์หัสในต้นทางแล้วยังไม่เปลี่ยน ไม่ควรเติมข้อมูลซ้ำซ้อนเพื่อทดลอง ต้องตรวจการเชื่อมต่อและการตั้งค่ารหัสก่อน

อ้างอิงโปรแกรม: src/pages/StaffPage.tsx; src/pages/LoginPage.tsx

26. แผนเริ่มใช้ที่โรงพยาบาลวชิรภูมิ

ให้โรงพยาบาลเลือกบริการเริ่มต้นเองและกำหนดผู้ประสานงาน หลีกเลี่ยงการสื่อสารที่มีการติดตั้งหรือเชื่อมต่อแล้วหากยังไม่ได้ยืนยัน

27. กิจวัตรประจำวันของทีม

ใช้เป็น checklist สำหรับทีม ปรับรอบตามการทำงานจริงของโรงพยาบาล ข้อตกลงที่ต้องได้คือใครตรวจ ใครแก้ ใครส่ง และใครติดตาม

28. คำถามและทดลองใช้งาน

ทวนเป้าหมายด้วยการให้ผู้เข้าอบรมอธิบายขั้นตอนจากเคสที่ฝึก รับคำถามเฉพาะหน้างาน และตกลงผู้ประสานงานกับรอบติดตามหลังเริ่มใช้งาน

ใบสรุปสำหรับผู้เข้าอบรม

ขั้นตอนที่ใช้ทุกวัน

1. เปิดรายการ OPD เลือกวันที่ กดดึงข้อมูลใหม่ และกรองข้อมูลรอแก้ไข
2. ตรวจ HN/VN วันบริการ สิทธิ และรายละเอียดบริการ
3. เปิดคู่มือกองทุน ค้นหาชื่อบริการหรือรหัส แล้วอ่าน Diag และคุ้รหัส
4. ตรวจหลักฐานจริง ให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขข้อมูลต้นทาง แล้วโหลดข้อมูลใหม่
5. ตรวจชุดรายการที่จะส่งและ Preview / Preflight
6. ส่งตามช่องทางที่กำหนด ตรวจผลรับข้อมูล และติดตาม REP/STM

คำถามก่อนคืนเพิ่ม

บริการเกิดขึ้นจริงหรือไม่ / รหัสอยู่ช่องข้อมูลใด / ต้องใช้รหัสคู่กันหรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง / ผูก visit ถูกหรือไม่ / ใครมีหน้าที่แก้และตรวจรับ

เมื่อพบปัญหา

จดวันเวลา เมนู ขั้นตอนที่ทำ และข้อความผิดพลาด ปกปิดข้อมูลผู้ป่วยก่อนส่งให้ผู้ดูแล ผ่านช่องทางที่โรงพยาบาลกำหนด

ขอบเขตเอกสาร

คู่มือนี้อิงโค้ด FDH Checker ที่ใช้เตรียมสอน ไม่ยืนยันว่าระบบโรงพยาบาลวาริชภูมิเชื่อมต่อแล้ว หรือหน่วยบริการมีสิทธิเบิกทุกรายการ ต้องตรวจประกาศที่ใช้กับวันบริการและการตั้งค่าจริง สถานะสมบูรณ์เป็นผลตรวจข้อมูลในโปรแกรม ไม่ใช่ผลอนุมัติจ่าย